



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PANDUAN RESEP

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 554.4/I-PND/DIR/VI/2025

Tentang
Panduan Resep

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Farmasi



(apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Resep Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Resep ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi data staff medis yang berwenang dalam peresepan, syarat elemen kelengkapan resep, dan beberapa instruksi khusus dalam peresepan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Resep ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 03 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Sadi Hariono, MMRS
2. dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N
3. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
4. dr. Akhmad Syahrir, Sp. N
5. dr. Andy, Sp. P
6. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
7. dr. Arianto Prabowo, Sp. OT
8. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
9. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
10. dr. Adya Sitaresmi, Sp.DV
11. dr. Andi Abdillah, Sp.B
12. drg. Ajeng Poerborani Ditaningtyas, Sp.KGA
13. drg. Bhakti Prasetyo Danaryudho, Sp. Ort.
14. dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp. P
15. dr. Dewi Maharani, Sp. S
16. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed
17. dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M
18. dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK
19. dr. Didid Roesono, Sp.KJ
20. drg. Ega Lucida Chandra Kumala, Sp. Perio
21. dr. Edi Wibowo, Sp.U
22. dr. Fahimma, Sp.N.M.Biomed
23. dr. Fachriy Balatif, Sp.BS
24. dr. Fiona Paramitha, Sp. A
25. dr. Heriyatmo, Sp. PD
26. dr. Humaira Rahma, Sp. OG
27. dr. Ira Setya Waty, Sp. JP
28. dr. I Gede Made Oka R., Sp. OT
29. Dr. dr. M. Kuntadi S. H., Sp. OT., M. Kes., MMR
30. dr. Meyrna Heryaning Putri, Sp. THT-KL
31. dr. Miryanti Cahyaningtyas, Sp. JP
32. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
33. dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M
34. dr. Nimin Putri Zahara, Sp. THT-KL
35. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
36. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A.,M.Biomed
37. dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp. B
38. dr. Rudy Vitraludyono, Sp. An
39. dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE., M.M
40. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
41. dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP (K)
42. dr. Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. PD
43. dr. Rino Rachmatullah
44. dr. Yuniar Ardy Santoso
45. dr. Annishafira Widyawardhani
46. dr. Gusti Gandha Pandya
47. dr. Isrotul Anisa
48. dr. Kezia Berlianti Rukmana
49. dr. Naufal Farid Dwi Rendragraha
50. dr. Yeni Octavia
51. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
52. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm

-
53. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
 54. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm
 55. apt. Ajeng Janani, S.Farm
 56. apt. Pipin Purwa N., S.Farm
 57. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm
 58. apt. Guspa Gayatri Azmi, S. Farm
 59. apt. Susanti, S. Farm
 60. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm.
 61. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
 62. Siti Durotul Ibadiah, S.Kep., Ns

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 2

 1.2.1 Maksud 2

 1.2.2 Tujuan Umum 2

 1.2.3 Tujuan Khusus..... 2

 1.3 Pengertian..... 2

BAB II RUANG LINGKUP..... 4

BAB III TATA LAKSANA..... 5

 3.1 Tenaga Medis yang Kompeten dan Berwenang melakukan Instruksi Pengobatan Umum dan Khusus 5

 3.2 Syarat Elemen Kelengkapan Resep..... 15

 3.3 Daftar Singkatan Pada Resep 20

 3.4 Penanganan Permasalahan Peresepan..... 23

 3.5 Penulisan Obat di Rekam Medis Pasien 24

 3.6 Penjelasan Tentang Obat, Cara Pakai, Peringatan 24

BAB IV PENUTUP..... 26

DOKUMENTASI..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peresepan Narkotika Saat Pasien Rawat Inap 6

Tabel 2. Peresepan Psikotropika Saat Pasien Rawat Inap..... 7

Tabel 3. Peresepan Narkotika Saat Pasien Rawat Jalan..... 10

Tabel 4. Peresepan Psikotropika Saat Pasien Rawat Jalan 11

Tabel 5. Daftar Dosis Maksimal untuk Obat Pro Re Nata (Jika Perlu) 16

Tabel 6. Kecepatan Pemberian Infus 16

Tabel 7. Daftar Obat *Automatic Stop Order*..... 19

Tabel 8. Daftar Singkatan pada Resep..... 20

Tabel 9. Tabel Pengenceran Obat..... 28

Tabel 10. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Epinephrine 31

Tabel 11. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Dobutamine 31

Tabel 12. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Norepinephrine 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh resep manual 27

Gambar 2. Contoh resep elektronik..... 27



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 554.4/I-PND/DIR/VI/2025**

TENTANG

PANDUAN RESEP

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 783.89/I-PND/DIR/VI/2022 tentang Panduan Resep sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Resep.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1818/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;



14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN RESEP**

**BAB I
PERESEPAN DOKTER**

Pasal 1

Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi tentang peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan yang harus ditulis secara benar, lengkap dan terbaca sesuai aturan penulisan resep.

Pasal 2

Dokter yang boleh menulis resep di RS Prima Husada adalah semua dokter yang telah memiliki SIP di RS Prima Husada yang mendapatkan Surat Penugasan Klinis dari Direktur Rumah Sakit serta memuat Rincian Kewenangan Klinis yang boleh dilakukan.

Pasal 3

Resep resmi harus ditulis oleh dokter peminta, bila pesanan obat per telepon, resep dituliskan oleh dokter jaga IGD sesuai dengan *advice* per telepon oleh dokter spesialis baik sesuai nama generik ataupun nama paten.

**BAB II
INSTRUKSI PENGobatan UMUM DAN KHUSUS**

Pasal 4

Semua dokter yang telah memiliki SIP di Rumah Sakit Prima Husada yang menulis resep/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan umum.

Pasal 5

Rumah sakit menetapkan dokter beserta daftar dokter yang berhak menulis resep/ permintaan obat/ memberi instruksi pengobatan khusus (psikotropika dan narkotika).

**BAB III
SYARAT ELEMEN KELENGKAPAN RESEP**

Pasal 6

Syarat elemen resep lengkap yang meliputi data identitas pasien secara akurat (dengan stiker), elemen pokok di semua resep atau permintaan obat atau instruksi pengobatan, penggunaan nama dagang atau generik, penggunaan indikasi seperti pada PRN (*pro re nata* atau "jika perlu") atau instruksi pengobatan lain, jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi



husus sejenis lainnya, kecepatan pemberian (jika berupa infus), instruksi khusus, sebagai contoh: titrasi, *tapering*, rentang dosis.

BAB IV PENANGANAN PERMASALAHAN PERESEPAN

Pasal 7

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses untuk menangani resep/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan. Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal di bawah ini:

1. Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap penulisan resep/ instruksi pengobatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca dengan cara merekap ketidaklengkapan penulisan resep dokter tiap akhir shift secara valid oleh petugas farmasi.
2. Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (*Look Alike Sound Alike*).
3. Jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti otomatis (*automatic stop order*), *tapering*, dan lainnya.
4. Instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan komunikasi efektif meliputi : tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi kepada dokter yang memberikan resep/ instruksi melalui telepon dan mencatat di rekam medis bahwa sudah dilakukan konfirmasi.

BAB VII PEMBATASAN JUMLAH RESEP

Pasal 8

Pembatasan jumlah resep atau jumlah pemesanan obat oleh staf medis yang mempunyai kewenangan memberi instruksi pengobatan khusus tablet maupun injeksi saat pasien rawat inap maupun rawat jalan.

Pasal 9

Resep Narkotika tidak boleh ada tanda *iter* (*iterasi*), m.i (*mihi ipsi*), u.c (*usus cognitus*) serta resep tidak boleh diulang, harus dengan resep asli dan baru.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 783.89/I-PND/DIR/VI/2022 tentang Panduan Resep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 03 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 554.4/I-PND/DIR/VI/2025
TENTANG
PANDUAN RESEP

PANDUAN RESEP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di banyak hasil penelitian, kesalahan obat (*medication error*) yang tersering terjadi di tahap peresepan. Jenis kesalahan peresepan antara lain: resep yang tidak lengkap, ketidaktepatan obat, dosis, rute dan frekuensi pemberian. Peresepan menggunakan tulisan tangan berpotensi tidak dapat dibaca. Penulisan resep yang tidak lengkap dan tidak terbaca dapat menyebabkan kesalahan dan tertundanya pasien mendapatkan obat.

Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi tentang peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan yang benar, lengkap dan terbaca. Rumah sakit menetapkan dan melatih tenaga medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat yang berdampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Persyaratan kelengkapan lain ditambahkan disesuaikan dengan jenis resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan, misalnya:

- a) Penulisan nama dagang atau nama generik pada sediaan dengan zat aktif tunggal.
- b) Penulisan indikasi dan dosis maksimal sehari pada obat PRN (pro renata atau "jika perlu").
- c) Penulisan berat badan dan/atau tinggi badan untuk pasien anak-anak, lansia, pasien yang mendapatkan kemoterapi, dan populasi khusus lainnya.
- d) Penulisan kecepatan pemberian infus di instruksi pengobatan.
- e) Penulisan instruksi khusus seperti: titrasi, tapering, rentang dosis.

Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap penulisan resep/ instruksi pengobatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca dengan cara merekap ketidaklengkapan penulisan resep dokter tiap akhir shift secara valid oleh petugas farmasi. Daftar obat yang diresepkan tercatat dalam rekam medis pasien yang mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Daftar ini menyertai pasien ketika dipindahkan sehingga profesional pemberi asuhan (PPA) yang merawat pasien dengan mudah dapat mengakses informasi tentang penggunaan obat pasien. Daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya agar pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan mematuhi aturan pakai yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

1. Rumah sakit menetapkan panduan resep sebagai acuan bagi tenaga medis yang kompeten dan berwenang tentang peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan yang harus ditulis secara benar, lengkap dan terbaca sesuai aturan penulisan resep.
2. Rumah sakit menetapkan panduan resep sebagai acuan bagi apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat dan bidan untuk menangani resep/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan.

1.2.2 Tujuan Umum

Tersedianya panduan resep di Rumah Sakit.

1.2.3 Tujuan Khusus

1. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat yang berdampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter.
2. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).
3. Menurunkan angka kesalahan penulisan resep.

1.3 Pengertian

- a. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Penulisan resep adalah tindakan terakhir dari dokter untuk pasien setelah melakukan anamnesis, diagnosis dan prognosis serta terapi yang akan diberikan.
- c. Pengkajian resep adalah proses kegiatan menelaah resep agar tidak terjadi kesalahan meliputi aspek administrasi, farmasetik, dan klinis.
- d. Resep narkotika meliputi peresepan tablet codein, codikaf, fentanyl, morfin, dan pethidine HCl.
- e. Resep psikotropika meliputi peresepan alprazolam, analsik, alena 1 mg, braxidin, clobazam, frixitas, merlopam, valisanbe, miloz, secadum, phenobarbital, dan stesolid rectal.
- f. Titrasi dosis adalah pemberian obat dimana dosis obat dinaikkan/ diturunkan secara bertahap dan terus-menerus sesuai respon yang dikehendaki (dapat berubah dalam hitungan jam, menit, atau detik) karena dosis bersifat dinamis. Instruksi harus terdiri dari: dosis awal, dosis titrasi, parameter penilaian, dan titik akhir penggunaan.
- g. *Standing order* adalah suatu instruksi dokter yang ditujukan kepada perawat atau professional kesehatan lain untuk memberikan intervensi kepada pasien selama dokter tidak ada di tempat. Contohnya pasien dengan demam tinggi berikan parasetamol, anak dengan kejang berikan diazepam rectal.
- h. *Tapering off* adalah intruksi pengobatan dimana dosis obat diturunkan secara bertahap sampai akhirnya dihentikan. Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi efek yang tidak diharapkan akibat penghentian mendadak. Tidak semua obat

dilakukan *dose tapering off*, hanya untuk obat-obatan yang memiliki sifat berlebihan pada tubuh yang akan dilakukan *tapering off*.

- i. *Automatic stop order* diterapkan pada obat-obatan kategori tertentu yang dianggap sebagai obat yang kuat/ poten dan obat-obat yang memerlukan review regular. Misal : antiinfeksi, antivirus, antifungi, narkotik, dan kortikosteroid. Jadi, pengobatan atau peresepan yang tidak disebutkan secara khusus tentang jumlah obat atau lama hari pengobatan, maka akan dikenai kebijakan automatic stop order. Pengobatan harus diresepkan untuk jangka waktu yang jelas, bukan menggunakan perkiraan waktu (misal: “dilanjutkan hingga pemberitahuan berikutnya” atau “dilanjutkan hingga pasien dipulangkan”).
- j. Instruksi rentang dosis adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat dinyatakan dalam rentang.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Rumah sakit menetapkan tenaga medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/ permintaan obat serta instruksi pengobatan.
2. Manajemen obat yang baik melakukan dua hal untuk dinilai di setiap resep atau setiap ada pesanan obat. Pengkajian resep untuk menilai ketepatan baik administratif, farmasetik, maupun klinis untuk pasien dan kebutuhan kliniknya pada saat resep dibuat atau obat dipesan. Pengkajian resep dilakukan oleh apoteker.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Tenaga Medis yang Kompeten dan Berwenang melakukan Instruksi Pengobatan Umum dan Khusus

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi tentang peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan yang benar, lengkap dan terbaca. Rumah sakit menetapkan dan melatih tenaga medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan.

Peresepan/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan harus ditulis secara benar, lengkap, dan terbaca sesuai aturan penulisan resep. Dokter yang boleh menulis resep di RS Prima Husada adalah semua dokter yang telah memiliki SIP di Rumah Sakit Prima Husada yang mendapatkan Surat Penugasan Klinis dari Direktur Rumah Sakit serta memuat Rincian Kewenangan Klinis yang boleh dilakukan. Resep resmi harus ditulis oleh dokter peminta, bila pesanan obat per telepon, resep dituliskan oleh dokter jaga IGD sesuai dengan *advice* per telepon oleh dokter spesialis baik sesuai nama generik ataupun nama paten.

Semua dokter yang telah memiliki SIP di Rumah Sakit Prima Husada yang menulis resep/ permintaan obat/ memberi instruksi pengobatan umum. Rumah Sakit menetapkan dokter beserta daftar dokter yang berhak menulis resep/ permintaan obat/ memberi instruksi pengobatan khusus (narkotika dan psikotropika).

Daftar staf medis berwenang melakukan instruksi pengobatan khusus

Tabel 1. Peresepan Narkotika Saat Pasien Rawat Inap

NO	NAMA OBAT	SPESIALISASI DOKTER									
		DOKTER UMUM	DOKTER GIGI, KONSERVASI GIGI, ORTODONSIA		ANESTESI	BEDAH	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	KEJIWAAN	KULIT KELAMIN	MATA
	NARKOTIKA										
1	Morfin 10 mg/ ml	-	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
2	Codein 10 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-		15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
3	Codein 15 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-		15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
4	Codein 20 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-		15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
5	Fentanyl inj	-	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap
6	Pethidin HCl inj	-	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
NO	NAMA OBAT	PARU	PATOLOGI KLINIK	PENYAKIT DALAM	OBGYN	ORTOPEDI	RADIOLOGI	SARAF	THT	UROLOGI	ANAK
1	Morfin 10 mg/ ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Codein 10 mg	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	15 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap
3	Codein 15 mg	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	15 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap
4	Codein 20 mg	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	15 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
5	Fentanyl inj	-	-	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap	-
6	Pethidin HCl inj	-	-	-	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	1 amp/ pasien/ rawat inap	1 amp/ pasien/ rawat inap	-

Tabel 2. Peresepan Psikotropika Saat Pasien Rawat Inap

NO	NAMA OBAT	SPESIALISASI DOKTER								
		DOKTER UMUM	DOKTER GIGI, KONSERVASI GIGI, ORTODONSIA	ANESTESI	BEDAH	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	KEJIWAAN	KULIT KELAMIN	MATA
		PSIKOTROPIKA								
1	Analsik	5 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	-	10 tab/ pasien/ rawat inap
2	Alena 1 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-

3	Miloz inj	-	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	-	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
4	Sedacum inj	-	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	-	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-
5	Valisanbe 5 mg inj	3 amp/ pasien/ rawat inap	-		3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-
6	Frixitas 1 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
7	Stesolid rectal	3 supp/ pasien/ rawat inap	-		3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	5 supp/ pasien/ rawat inap	-	-
8	Alprazolam 0,5 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
9	Clobazam 10 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
10	Valisanbe 2 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	2 tab/ pasien/ rawat inap
11	Valisanbe 5 mg tab	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	2 tab/ pasien/ rawat inap
12	Braxidin	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		15 tab/ pasien/ rawat inap	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-	-
13	Merlopam 0,5 mg	1 tab/ pasien/ rawat inap	-		-	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
14	Merlopam 2 mg	-	-		-	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-
NO	NAMA OBAT	PARU	PATOLOGI KLINIK	PENYAKIT DALAM	OBGYN	ORTOPEDI	RADIOLOGI	SARAF	THT	UROLOGI	ANAK

1	Analsik	10 tab/ pasien/ rawat inap	-	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	-	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap	10 tab/ pasien/ rawat inap
2	Alena 1 mg	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-
3	Miloz inj	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sedacum inj	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Valisanbe 5 mg inj	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	-	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap	3 amp/ pasien/ rawat inap
6	Frixitas 1 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-
7	Stesolid rectal	3 supp/ pasien/ rawat inap	-	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	-	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap	3 supp/ pasien/ rawat inap
8	Alprazolam 0,5 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-
9	Clobazam 10 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-
10	Valisanbe 2 mg	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap

11	Valisanbe 5 mg tab	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap	5 tab/ pasien/ rawat inap
12	Braxidin	10 tab/ pasien/ rawat inap	-	15 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-	10 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-
13	Merlopam 0,5 mg	-	-	-	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-
14	Merlopam 2 mg	-	-	-	-	-	-	5 tab/ pasien/ rawat inap	-	-	-

Tabel 3. Peresepan Narkotika Saat Pasien Rawat Jalan

NO	NAMA OBAT	SPESIALISASI DOKTER								
		DOKTER UMUM	DOKTER GIGI, KONSERVASI GIGI, ORTODONSIA	ANESTESI	BEDAH	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	KEJIWAAN	KULIT KELAMIN	MATA
	NARKOTIKA									
1	Morfin 10 mg/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Codein 10 mg	10 tab/ bulan	-	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	-
3	Codein 15 mg	10 tab/ bulan	-	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	-
4	Codein 20 mg	10 tab/ bulan	-	15 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	-
5	Fentanyl inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	Pethidin HCl inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO	NAMA OBAT	PARU	PATOLOGI KLINIK	PENYAKIT DALAM	OBGYN	ORTOPEDI	RADIOLOGI	SARAF	THT	UROLOGI	ANAK
1	Morfin 10 mg/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Codein 10 mg	30 tab/ bulan	-	30 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	10 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	-	4 tab/ bulan/ pasien
3	Codein 15 mg	30 tab/ bulan	-	30 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	10 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	-	4 tab/ bulan/ pasien
4	Codein 20 mg	30 tab/ bulan	-	30 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	10 tab /bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	-	-
5	Fentanyl inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pethidin HCl inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Peresepan Psikotropika Saat Pasien Rawat Jalan

NO	NAMA OBAT	SPESIALISASI DOKTER								
		DOKTER UMUM	DOKTER GIGI, KONSERVASI GIGI, ORTODONSIA	ANESTESI	BEDAH	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	KEJIWAAN	KULIT KELAMIN	MATA
		PSIKOTROPIKA								
1	Analsik	10 tab/ bulan/ pasien	20 tab/ bulan/ pasien	15 tab/ bulan/ pasien	20 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	30 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	-	20 tab/ bulan/ pasien

2	Alena 1 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	10 tab/ bulan/ pasien	-	-	
3	Miloz inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sedacum inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Valisanbe 5 mg inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Frixitas 1 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	15 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab /bulan/ pasien	-	-	
7	Stesolid rectal	3 supp/ bulan/ pasien	-	3 supp/ bulan/ pasien	5 supp/ bulan/ pasien	5 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien	30 supp/ bulan/ pasien	-	-	
8	Alprazolam 0,5 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	15 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
9	Clobazam 10 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	15 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
10	Valisanbe 2 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	15 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
11	Valisanbe 5 mg tab	5 tab/ bulan/ pasien	-	15 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
12	Braxidin	15 tab/ bulan	-	15 tab/ bulan/ pasien	15 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	-	-	
13	Merlopam 0,5 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	-	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
14	Merlopam 2 mg	-	-	-	-	-	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	
NO	NAMA OBAT	PARU	PATOLOGI KLINIK	PENYAKIT DALAM	OBGYN	ORTOPEDI	RADIOLOGI	SARAF	THT	UROLOGI	ANAK
1	Analsik	30 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	10 tab/bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	-	10 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	10 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien

2	Alena 1 mg	-	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	10 tab/ bulan/ pasien	-	-	-
3	Miloz inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sedacum inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Valisanbe 5 mg inj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Frixitas 1 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-
7	Stesolid rectal	3 supp/ bulan/ pasien	-	5 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien	-	5 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien	3 supp/ bulan/ pasien
8	Alprazolam 0,5 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-
9	Clobazam 10 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-
10	Valisanbe 2 mg	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien
11	Valisanbe 5 mg tab	5 tab/ bulan/ pasien	-	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien	5 tab/ bulan/ pasien
12	Braxidin	10 tab/ bulan/ pasien	-	30 tab/ bulan/ pasien	-	-	-	10 tab/ bulan/ pasien	-	-	-
13	Merlopam 0,5 mg	-	-	-	-	-	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-

14	Merlopam 2 mg	-	-	-	-	-	-	5 tab/ bulan/ pasien	-	-	-
----	---------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---	---	---

3.2 Syarat Elemen Kelengkapan Resep

Untuk menghindari keragaman dan menjaga keselamatan pasien maka rumah sakit menetapkan persyaratan atau elemen penting kelengkapan suatu resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan, persyaratan atau elemen kelengkapan meliputi :

1. Data identitas pasien secara akurat
Data identitas pasien secara akurat berupa stiker dan sudah terintegrasi dengan SIMRS sehingga dapat menjamin kebenaran identitas lebih akurat. Identitas pasien terdiri dari nama, alamat, tanggal lahir dan umur, no RM, berat badan dan tinggi badan. Lengkapnya identitas pasien akan menguntungkan/ memudahkan penelusuran tempat tinggal pasien bila terjadi masalah/ kesalahan dalam melayani obat.
2. Elemen pokok pada resep/permintaan obat/instruksi pengobatan
Elemen pokok pada resep meliputi persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinis.
3. Identitas dokter.
Meliputi nama dan nomor surat ijin praktik penulis resep.
Pada resep *electronic* sudah tercetak dalam blanko resep.
4. Tanggal ditulis resep.
Tanggal diperlukan dalam pelayanan resep, berkaitan dengan persyaratan dalam perundang- undangan. Pada resep *electronic* sudah tercetak dalam blanko resep.
5. Superscriptio.
Bagian ini merupakan kelengkapan dalam resep dokter. Ditulis dengan simbol R/ (recipe = harap diambil). Biasanya juga sudah dicetak dalam blanko resep, terletak di sisi kiri atas hanya tercetak satu R/, sehingga bila diberikan lebih satu formula resep, diperlukan penulisan R/ lagi.
Pada resep *electronic* sudah tercetak dalam blanko resep.
6. Inscriptio.
Bagian ini merupakan inti resep dokter, berisi nama obat, kekuatan dan jumlah obat yang diperlukan serta ditulis secara jelas. Penulisan nama obat dapat menggunakan nama generik atau nama dagang. Penulisan jumlah dan kekuatan obat dalam satuan berat atau volume dengan sistim metrik (mg, g, ml, l) dan dengan angka arab. Penulisan jumlah obat dalam satuan biji (tablet, kapsul, botol, bungkus, dll) dengan angka romawi.
7. Subscriptio.
Bagian ini mencantumkan bentuk sediaan obat dan jumlahnya. Cara penulisan (dengan singkatan bahasa latin) tergantung dari macam formula resep yang digunakan.
Contoh :
m.f.l.a. pulv. D.t.d. no. XX
m.f.l.a. sol.
m.f.l.a. pulv. No. XXX da in caps.
8. Signatura.
Bagian ini berisi informasi tentang aturan penggunaan obat untuk pasien, yaitu meliputi frekuensi, jumlah obat dan saat diminum obat, untuk setiap hari, serta

lain-lain informasi yang mungkin perlu diberikan, jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya.

Simbol (singkatan Latin) yang digunakan adalah s (= signatura tandailah).

Contoh :

s.t.d.d. tab. l u.h. p.c. (tandailah tiga kali sehari satu tablet satu jam setelah makan)
s.t.d.d 20 tpm (kecepatan pemberian infus tertulis dalam resep)

Walaupun aturan penggunaan obat oleh pasien, sudah ditulis dalam resep, dokter berkewajiban pula menjelaskan (secara lisan) pada pasien saat resep diserahkan ke pasien.

9. Penggunaan nama dagang atau generik.
Peresepan dokter di RS Prima Husada melalui *e-resep*, sehingga dokter dapat langsung menentukan nama dagang atau generik. Penggunaan nama dagang dan generik sebagai berikut :
- a. Peresepan pada pasien BPJS mendapatkan obat generik sesuai instruksi Dokter dan tersedia di Formularium Nasional.
 - b. Peresepan pada pasien UMUM/BPJS naik kelas VVIP/ asuransi lain mendapatkan obat generik dan/ atau paten sesuai instruksi Dokter.
10. Penggunaan indikasi seperti pada PRN (pro re nata atau “jikaperlu”) atau instruksi pengobatan lain.
Penulisan k/p, atau prn harus disertai dengan indikasi penggunaan atau kapan diperlukannya. Contohnya : prn sakit kepala atau prn mual. Kemudian disertakan dosis maksimal untuk pemakaian satu hari. PRN biasanya digunakan untuk obat analgetik, antipiretik dan antidiare.

Tabel 5. Daftar Dosis Maksimal untuk Obat Pro Re Nata (Jika Perlu)

Nama Obat	Dosis max/hari	Nama Obat	Dosis max/hari
Asam mefenamat 500 mg	4 gram/hari	Analsik	4 tablet/hari
Domperidone 10 mg	40 mg/ hari	Tramadol 50 mg	300 mg/ hari
Ondansentron 8 mg	32 mg/hari	Betahistine 6 mg	36 mg/ hari
New diatab 600 mg	12 tablet/hari	Salbutamol 4 mg	16 mg/ hari
Loperamid 10 mg	8 tablet/hari	N-Ace 200 mg	600 mg/ hari
Ibuprofen 400 mg	2,4 g/hari	Codein 10 mg	60 mg/ 24 jam
Parasetamol 500 mg	8 tablet/hari		

11. Jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya.
12. Kecepatan pemberian (jika berupa infus). Kecepatan pemberian infus harus tertulis pada peresepan infus.

Tabel 6. Kecepatan Pemberian Infus

Makro	Mikro
-------	-------

30 tpm → 5 jam	30 tpm → 16 jam
26 tpm → 6 jam	26 tpm → 19 jam
24 tpm → 7 jam	24 tpm → 20 jam
20 tpm → 8 jam	20 tpm → 25 jam
18 tpm → 9 jam	18 tpm → 27 jam
16 tpm → 10 jam	16 tpm → 31 jam
15 tpm → 11 jam	15 tpm → 33 jam
10 tpm → 17 jam	10 tpm → 50 jam

13. Sebagai penutup dari bagian utama resep dokter adalah dengan ditulisnya tanda tangan/ paraf dokter penulis resep. Ini merupakan persyaratan bahwa resep sah untuk dilayani oleh apotek. Bila resep dokter mengandung obat narkotika dan psikotropika perlu dibubuhkan tanda tangan. Untuk obat golongan lain cukup dengan paraf. Resep anastesi narkotika psikotropika dan anastesi non-narkotika psikotropika secara *electronic* harus disertai resep dalam bentuk *paper* yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.

14. Instruksi khusus, sebagai contoh: titrasi, *tapering off*, *standing order*, *automatic stop order*, rentang dosis.

Instruksi dokter kepada professional pemberi asuhan untuk melaksanakan tugas pada saat dokter tidak ada di tempat. Instruksi dokter dapat diberikan oleh Dokter pada pasien tertentu, atau secara umum dengan persetujuan komite kedokteran.

a. Titrasi

Suatu instruksi pengobatan dimana dosis obat dinaikkan/ diturunkan secara bertahap dan terus-menerus sesuai respon yang dikehendaki (dapat berubah dalam hitungan jam, menit, atau detik) karena dosis bersifat dinamis. Instruksi harus terdiri dari: dosis awal, dosis titrasi, parameter penilaian, dan titik akhir penggunaan. Contoh obat yang memerlukan titrasi dosis antara lain obat-obat inotropik (dopamine, dobutamin, vascon, adrenalin), obat untuk koreksi elektrolit (KCl, MgSO₄, insulin), aminofilin, diazepam, morfin. Instruksi titrasi misalnya: infus nitrogliserin, dosis awal 5 mcg/menit. Naikkan dosis 5 mcg/menit setiap 5 menit jika nyeri dada menetap, jaga tekanan darah 110-140 mmHg.

b. *Tapering off*

Suatu intruksi pengobatan dimana dosis obat diturunkan secara bertahap sampai akhirnya dihentikan. Tujuan dilakukan *tapering off* pada beberapa obat adalah agar tidak terjadi efek yang tidak diharapkan akibat dosis obat tersebut dikurangi dan akhirnya dihentikan mendadak. Bila obat dihentikan secara mendadak, tubuh akan mengalami gejala putus obat. Obat-obatan yang bisa mengalami *tapering off* adalah kortikosteroid, β -blocker, antiepilepsi, dan antidepressan. Berikut obat-obat yang memerlukan *tapering off* :

1) Kortikosteroid

Obat ini memiliki efek anti inflamasi dengan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan mengembalikan peningkatan permeabilitas kapiler. Efek penekanan sistem imun terjadi dengan mekanisme penurunan aktivitas dan volume sistem limfatik, serta pada dosis tinggi dengan menekan fungsi adrenal.

Bila digunakan dalam dosis tinggi dan jangka panjang, kortikosteroid dapat menyebabkan penekanan fungsi kelenjar adrenal, penekanan sistem imun, sarcoma kaposi, miopati, efek pada mata, serta gangguan psikiatrik. Contoh obat kortikosteroid antara lain perdnison, dexamethasone,

methyprednisolon.

2) β -blocker

Beta blocker digunakan secara luas untuk mengobati berbagai kondisi termasuk hipertensi, infark miokardia, dan aritmia. Mengingat fungsi penting obat β -blocker dalam menjaga tekanan darah dan denyut jantung, sebagian besar pasien harus minum obat ini dalam jangka panjang. Meskipun demikian, terkadang perlu untuk menghentikan obat β -blocker bila ada kemungkinan pasien tidak dapat mentolerir efek samping dari obat. Sebelum dokter melakukan tapering off β -blocker, sangat penting untuk menentukan jenis formulasi yang cocok untuk pasien, serta memperhatikan kemampuan pasien untuk menerima efek dari obat tersebut.

Contoh obat β -blocker adalah bisoprolol, propranolol.

3) Antiepilepsi

Obat antiepilepsi adalah obat yang memerlukan perhatian untuk tapering off, dan jika dilakukan secara tidak benar kemungkinan akan terjadi kejang. Tidak jarang ditemukan pasien epilepsi yang mengkonsumsi lebih dari satu obat.

Ketika kebutuhan untuk *tapering off* antiepilepsi muncul, dianjurkan untuk pasien epilepsi agar dilakukan kontrol kejang yang lebih baik pada obat epilepsi baru dan memperhatikan dosis efektif pertama pengobatan dengan *tapering off*. Jika pasien telah bebas kejang dalam waktu lama dan berkelanjutan, dokter dapat mempertimbangkan penarikan obat antiepilepsi. Contoh obat epilepsi adalah phenytoin.

4) Anti depresan

Obat anti depresan dapat menyebabkan masalah ketika obat ini dihentikan semua secara tiba-tiba. Sindrom penghentian antidepresan dilaporkan terjadi pada satu dari lima pasien yang menghentikan obat secara tiba-tiba. Gejala umum yang terjadi antara lain insomnia, ketidakseimbangan dan gangguan sensorik. Penghentian obat antidepresan secara tiba-tiba dapat menyebabkan reaksi drastis terhadap tubuh yang disebabkan oleh merosotnya plasma obat. *Tapering off* antidepresan harus bertahap, menurun 25% untuk setiap periode, empat sampai enam minggu jika memungkinkan. Penilaian klinis dan kesejahteraan harus diprioritaskan ketika membuat keputusan tentang pengurangan jumlah obat antidepresan.

c. *Standing order*

Suatu instruksi dokter yang ditujukan kepada perawat atau professional kesehatan lain untuk memberikan intervensi kepada pasien selama dokter tidak ada di tempat. Contohnya pasien dengan demam tinggi berikan parasetamol, anak dengan kejang berikan diazepam rectal.

d. *Automatic stop order*

Kebijakan *automatic stop order* bertujuan untuk memastikan pemberian obat yang aman melalui proses stop order, terutama untuk beberapa obat yang harus dievaluasi dan ditinjau secara konsisten. Proses *automatic stop order* :

- 1) Apoteker mengingatkan dokter dan perawat jika mendapati suatu pengobatan yang hampir mencapai batas pemberian yang aman. Pengobatan akan dilanjutkan setelah dinyatakan secara tertulis oleh dokter yang bersangkutan.

- 2) Identifikasi dan komunikasi terkait *automatic stop order* akan disampaikan minimal 2x24 jam sebelum lama terapi habis.
 - 3) Apoteker akan mengirim peringatan tentang *automatic stop order* yang akan dilakukan.
 - 4) Komunikasi tersebut ditulis pada Buku Komunikasi Dokter dan/atau rekam medis pasien untuk pasien rawat inap.
- e. Intruksi rentang dosis
- Suatu instruksi pengobatan dimana dosis obat dinyatakan dalam rentang. Misalnya morfin inj 2-4 mg IV tiap 3 jam jika nyeri. Dosis disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien.

Tabel 7. Daftar Obat *Automatic Stop Order*

No.	Nama Obat	<i>Automatic Stop Order</i>
1.	Analgesik-AINS	
	Ketorolac injeksi	5 (lima) hari
	Ketorolac tablet	5 (lima) hari
2.	Anti koagulan	
	Enoxaparium: lovenox injeksi	7 (tujuh) hari
	Fondaparinux sodium: diviti injeksi	
	Warfarin : notisil 2 mg	14 (empat belas hari)
3.	Narkotika	
	Codein : codein 10 mg, codein 20 mg, codikaf 10 mg	30 (tiga puluh) hari
	Morfin injeksi	10 (sepuluh) hari
	Pethidine injeksi	
	Fentanyl injeksi	
4.	Proton Pump Inhibitor	
	Pantoprazole injeksi	3 (tiga) hari
5.	Anti jamur dan Antibiotik topikal dan sistemik, kecuali obat TB, antiretroviral, dan sampo ketoconazole	7 (tujuh) hari

Petugas farmasi yang berwenang melakukan telaah resep adalah Apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Lembaran resep dilayani apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinik meliputi :

No.	TELAAH ADMINISTRASI	LENGKAP	
		YA	TIDAK
1.	Nama, umur, jenis kelamin, BB, TB pasien		
2.	Nama, nomor ijin, alamat, dan paraf		
3.	Tanggal resep		
4.	Ruangan asal resep		

No.	TELAAH FARMASETIK	YA	TIDAK
1.	Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan		
2.	Dosis dan jumlah obat		
3.	Stabilitas		
4.	Aturan dan cara penggunaan		

No.	TELAAH KLINIS	YA	TIDAK
1.	Ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat		
2.	Duplikasi pengobatan		

3.	Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki		
4.	Kontra indikasi		
5.	Interaksi obat		
6.	Polifarmasi		
Nama & TTD Petugas :			

Obat dapat diserahkan kepada pasien apabila memenuhi persyaratan :

- Telaah obat :
1. Benar identitas pasien
 2. Benar obat
 3. Benar dosis
 4. Benar rute pemberian
 5. Benar waktu pemberian

3.3 Daftar Singkatan Pada Resep

Tabel 8. Daftar Singkatan pada Resep

Singkatan	Kepanjangan	Kesalahan dalam Interpretasi	Pembenaran
µg	Mikrogram	Sering salah dengan “mg”	Ditulis “mcg”
AD, AS, AU	Telinga kanan, telinga kiri, tiap telinga	Sering salah diartikan sebagai OD, OS, OU (mata kanan, mata kiri, tiap mata)	Gunakan “telinga kanan”, “telinga kiri”, “tiap telinga”
OS, OS, OU	Mata kanan, mata kiri, tiap mata	Sering salah diartikan sebagai AD, AS, AU (Telinga kanan, telinga kiri, tiap telinga)	Gunakan “mata kanan”, “mata kiri”, dan “tiap mata”
BT	Bedtime (saat waktu tidur)	Sering salah diartikan sebagai “BID” (dua kali sehari)	Gunakan “saat waktu tidur”
Cc	Centimeter cubic	Sering salah diartikan sebagai “u” (unit)	Gunakan “ml”
IJ	Injeksi	Sering salah diartikan sebagai “IV” atau “intrajugular”	Gunakan “injeksi”
IN	Intranasal	Sering salah diartikan sebagai “IM” atau “IV”	Gunakan “intranasal”
HS Hs	Half-strength (setengah kekuatan dosis) hours of sleep (saat waktu tidur)	Sering salah diartikan sebagai saat waktu tidur Sering salah diartikan sebagai setengah kekuatan dosis	Gunakan “setengah kekuatan dosis” atau “saat waktu tidur”
IU	International unit	Sering salah diartikan sebagai “IV” (intravena)	Gunakan “unit”
o.d atau OD	Once daily (sekali sehari)	Sering salah diartikan sebagai “OD” (mata kanan)	Gunakan “sekali sehari”
OJ	Orange juice	Sering salah diartikan sebagai OD atau OS (mata kanan atau kiri), obat seharusnya dilarutkan dalam jus jeruk dapat diberikan di mata	Gunakan “jus jeruk”

Per os	By mouth (secara oral)	Sering salah diartikan sebagai "OS" (mata kiri)	Gunakan "PO" atau secara oral
q.d atau QD	Setiap hari	Sering salah diartikan sebagai q.i.d	Gunakan "daily" atau harian
Qhs	Malam hari saat waktu tidur	Sering salah diartikan sebagai qhr (setiap jam)	Gunakan "malam hari"
Qn	Malam hari atau saat waktu tidur	Sering salah diartikan sebagai qh (setiap jam)	Gunakan "malam hari" atau "saat waktu tidur"
q.o.d. atau QOD	Tiap dua hari sekali	Sering salah diartikan sebagai "q.d." (setiap hari) atau "q.i.d." (empat kali sehari)	Gunakan "tiap dua hari sekali"
q1d	Setiap hari	Sering salah diartikan sebagai "q.i.d." (empat kali sehari)	Gunakan "setiap hari"
q6PM, dll.	Tiap jam 6 sore	Sering salah diartikan sebagai tiap 6 jam	Gunakan "jam 18.00"
SC	Subcutaneous	Sering salah diartikan sebagai SL (sublingual)	Gunakan subkutan
l/d	1 kali sehari	Sering salah diartikan sebagai "tid"	Gunakan "1 kali sehari"
TIW atau tiw	3 kali seminggu	Sering salah diartikan sebagai "3 kali sehari" atau "dua kali seminggu"	Gunakan "3 kali seminggu"
U atau u	Unit	Sering salah diartikan sebagai angka 0 atau 4, cc	Gunakan "unit"

Dosis Dan Informasi Lain	Pengertian	Kesalahan dalam Interpretasi	Pembenaran
1,0 mg	1 mg	10 mg jika koma tidak terlihat	Jangan gunakan angka "0" setelah koma untuk bilangan bulat
,5 mg	0,5 mg	5 mg jika koma tidak terlihat	Gunakan angka "0" sebelum koma
Nama obat dan dosis yang ditulis bersama (terutama nama obat dengan akhiran huruf "l" seperti Inderal40 mg, Tegretol300 mg)	Inderal 40 mg Tegretol 300 mg	Sering salah diartikan sebagai Inderal 140 mg Sering salah diartikan sebagai Tegretol 1300 mg	Beri jeda antara nama obat, dosis, dan jumlahnya
Dosis dan jumlah yang ditulis bersama (contoh 10mg, 100mL)	10 mg 100 mL	Huruf "m" sering salah diartikan sebagai "0" atau "00", risiko terjadi overdosis	Beri jeda antara dosis dan jumlahnya
Dosis dalam jumlah besara tanpa titik yang jelas (contoh 100000 unit, 1000000 unit)	100.000 unit 1.000.000 unit	10.000 unit 100.000 unit	Beri titik untuk dosis lebih dari atau sama dengan 1.000, atau gunakan kata seperti 100 "ribu" atau 1 "juta"

Singkatan Nama Obat	Pengertian	Kesalahan dalam Interpretasi	Pembenaran
APAP	Acetaminophen	Tidak diketahui dengan jelas	Gunakan nama obat lengkap
ARA A	vidarabine	Sering salah dengan cytarabine (ARA C)	Gunakan nama obat lengkap
AZT	zidovudine	Sering salah dengan azathioprine atau aztreonam	Gunakan nama obat lengkap
CPZ	Prochlorperazine	Sering salah dengan chlorpromazine	Gunakan nama obat lengkap
DPT	Demerol-Phenergan-Thorazine	Sering salah dengan diphtheria-pertussis-tetanus (vaksin)	Gunakan nama obat lengkap
DTO	Diluted tincture of opium (tincture opium yang diencerkan)	Sering salah dengan tincture opium	Gunakan nama obat lengkap
HCl	Hydrochloride	Sering salah dengan potassium chloride	Gunakan nama obat lengkap kecuali ditulis dalam bentuk garam
HCT	Hydrocortisone	Sering salah dengan hydrochlorothiazide	Gunakan nama obat lengkap
HCTZ	Hydrochlorothiazide	Sering salah dengan hydrocortisone	Gunakan nama obat lengkap
MgSO ₄	Magnesium sulfate	Sering salah dengan morphine sulfate	Gunakan nama obat lengkap
MS, MSO ₄	Morphine sulfate	Sering salah dengan magnesium sulfate	Gunakan nama obat lengkap
MTX	Methotrexate	Sering salah dengan mitoxantrone	Gunakan nama obat lengkap
PCA	Procainamide	Sering salah dengan patient controlled analgesia	Gunakan nama obat lengkap
PTU	Propylthiouracil	Sering salah dengan mercaptopurine	Gunakan nama obat lengkap
T3	Tyenol dengan kodein no. 3	Sering salah dengan liothyronine	Gunakan nama obat lengkap
TAC	Triamcinolone	Sering salah dengan tetracaine, adrenaline, kokain	Gunakan nama obat lengkap
TNK	TNKase	Sering salah dengan "TPA"	Gunakan nama obat lengkap
ZnSO ₄	Zinc sulfate	Sering salah dengan morphine sulfate	Gunakan nama obat lengkap

Nama Obat Ditulis Tidak Lengkap	Pengertian	Kesalahan dalam Interpretasi	Pembenaran
---------------------------------	------------	------------------------------	------------

“Nitro” drip	nitrogliserin infus	Sering salah diartikan sebagai sodium nitroprusside infus	Gunakan nama obat lengkap
“Norflox”	Norfloxacin	Sering salah diartikan sebagai Norflex	Gunakan nama obat lengkap
“IV Vanc”	Intravena vancomycin	Sering salah diartikan sebagai Invanz	Gunakan nama obat lengkap

Simbol	Pengertian	Kesalahan dalam Interpretasi	Pembenaran
x3d	Untuk tiga hari	Sering salah diartikan sebagai “3 dosis”	Gunakan “untuk tiga hari”
> dan <	Lebih dari dan kurang dari	Sering salah diartikan sebagai kebalikan, symbol yang salah, “<10 salah dengan 40”	Gunakan “lebih dari” atau “kurang dari”
/	Memisahkan dua dosis atau “per”	Sering salah diartikan sebagai angka 1 (contoh 25 unit/10 unit salah dengan 25 unit dan 110 unit”)	Gunakan “per” untuk memisahkan dosis
@	Pada	Sering salah diartikan sebagai “2”	Gunakan “pada”
&	Dan	Sering salah diartikan sebagai “2”	Gunakan “dan”
+	Plus atau dan	Sering salah diartikan sebagai “4”	Gunakan “dan”
°	Jam	Sering salah diartikan sebagai “0”	Gunakan “jam”

3.4 Penanganan Permasalahan Peresepan

1. Resep/ permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca.
Apabila terdapat Resep/ permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar/ tidak lengkap/ tidak terbaca maka apoteker atau tenaga teknik kefarmasian yang kompeten wajib mengkomunikasikan pada Dokter penulis resep dengan lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Setiap komunikasi harus tercatat pada Buku Komunikasi Dokter, kemudian dimintakan paraf dokter dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Resep/ permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (NamaObat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (*Look Alike Sound Alike*).
Apoteker atau tenaga teknik kefarmasian yang kompeten memberikan tanda lingkaran pada nama obat dan dosis pada permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM/LASA. Hal ini kemudian dikomunikasikan kepada petugas penyiap obat agar lebih berhati-hati. Sebelum penyerahan obat juga dilakukan pengecekan ulang oleh petugas farmasi terkait nama dan dosis obat sehingga terdapat *double barrier* dalam penangan obat NORUM/LASA.
3. Jenis resep khusus, seperti *emergency*, cito, berhenti otomatis (*automatic stop order*), tapering, dan lainnya. Apoteker memberi keterangan pada resep untuk pelayanan resep khusus seperti *emergency/ cito, automatic stop order, tapering off, standing order*, titrasi dosis.
4. Instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan komunikasi efektif meliputi : tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi kepada dokter yang memberikan resep/ instruksi 1x24 jam melalui telepon dan mencatat di rekam medis bahwa sudah dilakukan konfirmasi.

5. Jika terdapat peresepan dengan nama dagang yang tersedia maupun tidak di RS Prima Husada, maka petugas farmasi akan melakukan:
 - a. Pada pasien bpjs maka petugas farmasi berhak mengganti dengan obat generik sesuai Formularium Nasional dan terdapat di Formularium Rumah Sakit Prima Husada.
 - b. Pada pasien umum maka akan diberikan sesuai instruksi Dokter. Apabila obat dengan nama dagang tidak tersedia di RS Prima Husada, maka dikomunikasikan dengan Dokter bahwa obat tersebut tidak terdapat di RSPH. Dokter berhak memilih apakah obat mau diganti dengan jenis yang sama atau pasien dipersilahkan membeli obat di luar.
6. Jika terdapat peresepan obat diluar formularium RS dan instalasi farmasi tidak memiliki obat yang sejenis, namun obat tersebut terdapat di formularium nasional, maka dokter melakukan pengajuan obat baru. Obat tersebut dapat diberikan ke pasien umum maupun bpjs.
7. Jika terdapat peresepan obat diluar Formularium RS dan Formularium Nasional, namun instalasi farmasi tidak memiliki obat yang sejenis, maka dokter melakukan pengajuan obat baru. Obat tersebut hanya dapat diberikan ke pasien umum. Peresepan diluar Formularium Nasional hanya dapat diberikan untuk pasien umum.

Standar ini berlaku untuk resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan di semua unit pelayanan di rumah sakit.

3.5 Penulisan Obat di Rekam Medis Pasien

Obat yang diresepkan dan diberikan tercatat di rekam medis pasien, yaitu Daftar Pemberian Obat. Rekam medis pasien memuat daftar obat yang diinstruksikan yang memuat identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter serta keterangan bila perlu *tapering off*, atau titrasi. Pencatatan juga termasuk obat yang diberikan “jika perlu”/ prorenata. Pencatatan dibuat di daftar obat yang tersendiri dan dimasukkan ke dalam berkas rekam medis. Daftar ini menyertai pasien ketika dipindahkan sehingga profesional pemberi asuhan (PPA) yang merawat pasien dengan mudah dapat mengakses informasi tentang penggunaan obat pasien. Daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya agar pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan mematuhi aturan pakai yang sudah ditetapkan.

3.6 Penjelasan Tentang Obat, Cara Pakai, Peringatan

Setelah resep ditulis, kita harus menjelaskan tentang berbagai hal kepada pasien yaitu:

1. Kandungan obat dan dosis
Pasien perlu mengetahui kandungan obat apa yang diminum dan dosis yang digunakan. Hal ini untuk meminimalkan pasien salah mengkonsumsi obat.
2. Efek obat/ khasiat
Efek utama obat yang menjadi dasar pilihan kita untuk mengatasi permasalahan/diagnosis perlu dijelaskan kepada pasien, misalnya gejala demam dan pusing akan berkurang atau hilang.
3. Efek samping

Demikian pula efek samping yang mungkin muncul akibat menggunakan obat. Namun perlu bijaksana, agar pasien tidak justru menjadi takut karenanya, yang penting pasien tahu dan bisa mengantisipasi bila efek samping itu muncul, misalnya hipoglikemia akibat obat anti diabetes, mengantuk akibat anti-histamin, dll

4. Instruksi/ cara menggunakan

Pasien harus jelas tentang saat minum obat, cara minum obat, misalnya obat diminum 3 kali (pagi, siang dan malam, sesudah/sebelum makan, dengan cukup air, dst.), cara menyimpannya, apa yang harus dilakukan bila ada masalah dst. Antibiotika misalnya harus diminum sampai habis sesuai dengan jumlah yang diresepkan, sedangkan beberapa obat digunakan hanya bila diperlukan saja. Ada obat yang diminum secara bertahap dengan dosis berangsur-angsur naik dan setelah itu berangsur-angsur turun (kortikosteroid).

5. Peringatan

Terkait dengan efek samping, misalnya tidak boleh mengemudi dan menjalankan mesin karena efek kantuk obat. Kunjungan berikutnya: jadwal kunjungan berikutnya ke dokter (untuk evaluasi dan monitor terapi).

6. Pasien perlu ditanya apakah semua informasi yang diberikan telah dimengerti dengan baik. Pasien bisa diminta untuk mengulang segenap informasi yang telah disampaikan.

BAB IV

PENUTUP

Rumah Sakit menetapkan dan menerapkan regulasi peresepan/ permintaan obat dan bahan medis habis pakai atau intruksi pengobatan yang benar, lengkap, dan terbaca.

Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis yang kompeten dan berwenang yang bekerja di Rumah Sakit Prima Husada dalam melakukan peresepan/ permintaan obat dan bahan medis habis pakai atau intruksi pengobatan untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat yang berdampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Serta menjadi acuan bagi apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat dan bidan untuk menangani resep/ permintaan obat dan BMHP/ instruksi pengobatan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI

4.1 Resep manual

INSTALASI FARMASI

RS. PRIMA HUSADA

Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko - Malang
Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax : 441874

UMUM

Tanggal : 13-04-2025

No. ID : 061746

Dokter : dr. Zoraida Dwi W, Sp.PD

No. R/ : 10029

Riwayat Alergi Obat: ☒ Tidak ☐ Ya, Nama Obat : -

R/ Adalat 100s tab 30 mg No. xxx

S 1-0-0 pc

R/ Glimepirid tab 3mg No. xxx

S 1-0-0 ac

R/ Can desartan tab 16 mg No. xxx

S 0-0-1 pc

R/ Clopidogrel tab 75 mg No. xxx

S 1dd1 pc

R/ metformin tab 500mg No. LX

S 2dd1 pc

Tindakan / GDA: Rp.

Nama Pasien	: Dwi Amalina	I	: Yr
Alamat	: Jl. Sumpah, Singosari	S	: Pm
Tgl. Lahir/Umur	: 02/07/1964 / 61 tahun	E	: Pm
BB/TB	: 56 kg / 150 cm	P	: Pm

Gambar 1. Contoh resep manual

4.2 Resep Elektronik

INSTALASI FARMASI

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Banjararum Selatan No.3 Mondoroko - Malang
Telp. (0341)-458679, Fax. (0341)-441874

BPJS

11/04/2025 13:30:34

RESEP DOKTER

Nama dan Tanda tangan Dokter

No. R/ : RJ/2509110152

dr. Akhmad Syahrir Sp. N

Tanggal : 11/04/2025 13:29

Unit : Klinik Saraf

Alergi Obat :

R/ NOSPIRINAL TAB 80 MG - NOVELL No. XXX

S1-0-0 sesudah makan, Rute: Oral, Ket. lain: pagi

R/ ALLOPURINOL TAB 100 MG - HEXPHARM JAYA No. XXX

S0-0-1 sesudah makan, Rute: Oral, Ket. lain: malam

R/ AMLODIPIN TAB 10 MG - HEXPHARM JAYA No. XXX

S1-0-0 sesudah makan, Rute: Oral, Ket. lain: pagi

R/ CANDESARTAN TAB 16 MG - HEXPHARM JAYA No. XXX

S0-0-1 sesudah makan, Rute: Oral, Ket. lain: malam

R/ METFORMIN TAB 500 MG - HEXPHARM JAYA No. LX

S2dd1 sesudah makan, Rute: Oral, Ket. lain: pagi, sore

Nama Pasien : RIA AMALIA

No. RM : 044505

Jns. Kelamin : Perempuan

BB : 75 kg

Tgl. Lhr/Umur : 19/03/1981 / 44th 5bln 23hr

TB : 155 cm

Alamat : PERUM ARDIMULYO SONG SONG A2 RT. 03

RW. 02 KEL. ARDIMULYO Kec. SINGOSARI KAB

Hal : 1/3

MALANG JAWA TIMUR

Gambar 2. Contoh resep elektronik

4.3 Tabel Pengenceran Obat

Tabel 9. Tabel Pengenceran Obat

NO	NAMA SEDIAAN OBAT	PENGECERAN (dalam 50 ml)	RATE INFUSSION	KETERANGAN	TETESAN/MIN
1	Dopamin 1 ampul 200 mg/10 ml	$= \frac{200.000}{50}$ $= 4000 \text{ mcg/ml}$ <i>Compatible</i> dengan NS, D5W, D10W, RL, D5/NS.	$\text{Rate of infussion} = \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$	<u>Contoh</u> BB = 60 kg <i>Rate of infussion</i> $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$ <u>Contoh</u> $= \frac{5 \text{ mcg} \times 60 \text{ kg} \times 60 \text{ min}}{4000 \text{ mcg/ml}}$ = 4,5 ml/jam	Bila menggunakan infus macro Maka, 1 cc = 20 tts/mnt Hasil $= \frac{4,5 \text{ ml/jam} \times 20 \text{ tts/mnt}}{60 \text{ menit}}$ = 1,5 tts/menit Bila infus mikro, 1 cc = 60 tts/mnt
2	Dobutamine 1 ampul 250 mg/5 ml	$= \frac{250.000}{50}$ $= 5000 \text{ mcg/ml}$ <i>Compatible</i> dengan NS, D5W, RL, D5/RL. D5/NS.	$\text{Rate of infussion} = \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$	<u>Contoh</u> BB = 60 kg <i>Rate of infussion</i> $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$ <u>Contoh</u> $= \frac{5 \text{ mcg} \times 60 \text{ kg} \times 60 \text{ min}}{5000 \text{ mcg/ml}}$ = 3,6 ml/jam	Bila menggunakan infus macro Maka, 1 cc = 20 tts/mnt Hasil $= \frac{3,6 \text{ ml/jam} \times 20 \text{ tts/mnt}}{60 \text{ menit}}$ = 1,2 tts/menit Bila infus mikro, 1 cc = 60 tts/mnt
3	Norephinefrine 1 ampul 4 mg/ 4 ml	$= \frac{4.000}{50}$ $= 80 \text{ mcg/ml}$	$\text{Rate of infussion} = \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$	<u>Contoh</u> BB = 60 kg <i>Rate of infussion</i>	Bila menggunakan infus macro

		Compatible dengan NS atau D5W		$= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$ Contoh $= \frac{1 \text{ mcg} \times 60 \text{ kg} \times 60 \text{ min}}{80 \text{ mcg/ml}}$ $= 45 \text{ ml/jam}$	Maka, 1 cc = 20 tts/mnt Hasil $= \frac{45 \text{ ml/jam} \times 20 \text{ tts/mnt}}{60 \text{ menit}}$ $= 15 \text{ tts/menit}$ Bila infus mikro, 1 cc = 60 tts/mnt
4	Aminofilin 1 ampul 240 mg/ 10 ml	$= \frac{240.000}{50}$ $= 4800 \text{ mcg/ml}$ Compatible dengan D5W, D5-1/2NS, RL, NS)	Rate of infussion $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$	Contoh BB = 60 kg Rate of infussion $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$ Contoh $= \frac{5 \text{ mcg} \times 60 \text{ kg} \times 60 \text{ min}}{4800 \text{ mcg/ml}}$ $= 3,75 \text{ ml/jam}$	Bila menggunakan infus macro Maka, 1 cc = 20 tts/mnt Hasil $= \frac{3,75 \text{ ml/jam} \times 20 \text{ tts/mnt}}{60 \text{ menit}}$ $= 1,25 \text{ tts/menit}$ Bila infus mikro, 1 cc = 60 tts/mnt
5	Morfin 1 ampul 10 mg/ 1 ml	$= \frac{10.000}{50}$ $= 200 \text{ mcg/ml}$ Compatible dengan D5.	Rate of infussion $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$	Contoh BB = 60 kg Rate of infussion $= \frac{\text{dosis yang diminta} \times \text{BB} \times 60 \text{ min}}{\text{konsentrasi obat}}$ Contoh $= \frac{1 \text{ mcg} \times 60 \text{ kg} \times 60 \text{ min}}{200 \text{ mcg/ml}}$ $= 18 \text{ ml/jam}$	Bila menggunakan infus macro Maka, 1 cc = 20 tts/mnt Hasil $= \frac{18 \text{ ml/jam} \times 20 \text{ tts/mnt}}{60 \text{ menit}}$ $= 6 \text{ tts/menit}$ Bila infus mikro, 1 cc = 60 tts/mnt

--	--	--	--	--	--

4.4 Tabel Kecepatan Alir Dengan Syringe Pump Epinephrine

1 ampul Epinephrine dalam 50 ml (Kompatibel dengan NS, RL, D5/NS, D10W, D5W).
1 ampul = 1 mg/1 ml
Konsentrasi larutan Epinephrine 20 mcg

Tabel 10. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Epinephrine

Dosis (mcg/kg/mnt)	Kecepatan Alir (ml/jam)						
0,05	6	6,75	7,5	8,25	9	9,75	10,5
0,1	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21
0,15	18	20,25	22,5	24,75	27	29,25	31,5
0,2	24	27	30	33	36	39	42
0,25	30	33,75	37,5	41,25	45	48,75	52,5
0,3	36	40,5	45	49,5	54	58,5	63
0,35	42	47,25	52,5	57,75	63	68,25	73,5
0,4	48	54	60	66	72	78	84
0,45	54	60,75	67,5	74,25	81	87,75	94,5
0,5	60	67,5	75	82,5	90	97,5	105
0,55	66	74,25	82,5	90,75	99	107,25	115,5
0,6	72	81	90	99	108	117	126
0,65	78	87,75	97,5	107,25	117	126,75	136,5
0,7	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147
0,75	90	101,25	112,5	123,75	135	146,25	157,5
0,8	96	108	120	132	144	156	168
0,85	102	114,75	127,5	140,25	153	165,75	178,5
0,9	108	121,5	135	148,5	162	175,5	189
0,95	114	128,25	142,5	156,75	171	185,25	199,5
1	120	135	150	165	180	195	210

Tabel Kecepatan Alir Dengan Syringe Pump Dobutamine

1 ampul Dobutamine dalam 50 ml (Kompatibel dengan NS, D5W, RL, D5/RL. D5/NS)
1 ampul = 250 mg/5 ml
Konsentrasi larutan dobutamine 5000 mcg

Tabel 11. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Dobutamine

Dosis (mcg/kg/mnt)	Kecepatan Alir (ml/jam)						
2	0,96	1,08	1,2	1,32	1,44	1,56	1,68
2,5	1,2	1,35	1,5	1,65	1,8	1,95	2,1
3	1,44	1,62	1,8	1,98	2,16	2,34	2,52
3,5	1,68	1,89	2,1	2,31	2,52	2,73	2,94
4	1,92	2,16	2,4	2,64	2,88	3,12	3,36
4,5	2,16	2,43	2,7	2,97	3,24	3,51	3,78
5	2,40	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2
5,5	2,64	2,97	3,3	3,63	3,96	4,29	4,62
6	2,88	3,24	3,6	3,96	4,32	4,68	5,04
6,5	3,12	3,51	3,9	4,29	4,68	5,07	5,46
7	3,36	3,78	4,2	4,62	5,04	5,46	5,88
7,5	3,60	4,05	4,5	4,95	5,4	5,85	6,3

8	3,84	4,32	4,8	5,28	5,76	6,24	6,72
8,5	4,08	4,59	5,1	5,61	6,12	6,63	7,14
9	4,32	4,86	5,4	5,94	6,48	7,02	7,56
9,5	4,56	5,13	5,7	6,27	6,84	7,41	7,98
10	4,80	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,4
10,5	5,04	5,67	6,3	6,93	7,56	8,19	8,82
11	5,28	5,94	6,6	7,26	7,92	8,58	9,24
11,5	5,52	6,21	6,9	7,59	8,28	8,97	9,66
12	5,76	6,48	7,2	7,92	8,64	9,36	10,08
12,5	6,00	6,75	7,5	8,25	9	9,75	10,5
13	6,24	7,02	7,8	8,58	9,36	10,14	10,92
13,5	6,48	7,29	8,1	8,91	9,72	10,53	11,34
14	6,72	7,56	8,4	9,24	10,08	10,92	11,76
14,5	6,96	7,83	8,7	9,57	10,44	11,31	12,18
15	7,20	8,1	9	9,9	10,8	11,7	12,6
15,5	7,44	8,37	9,3	10,23	11,16	12,09	13,02
16	7,68	8,64	9,6	10,56	11,52	12,48	13,44
16,5	7,92	8,91	9,9	10,89	11,88	12,87	13,86
17	8,16	9,18	10,2	11,22	12,24	13,26	14,28
17,5	8,40	9,45	10,5	11,55	12,6	13,65	14,7
18	8,64	9,72	10,8	11,88	12,96	14,04	15,12
18,5	8,88	9,99	11,1	12,21	13,32	14,43	15,54
19	9,12	10,26	11,4	12,54	13,68	14,82	15,96
19,5	9,36	10,53	11,7	12,87	14,04	15,21	16,38
20	9,60	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8
Berat Badan (kg)	40	45	50	55	60	65	70

4.5
Tabel Kecepatan Alir Dengan Syringe Pump Norephinefrine/ Vascon

1 ampul Norepinephrine dalam 50 ml (Kompatibel dengan NS, D5W).
1 ampul = 4 mg/4 ml
Konsentrasi larutan Norepinephrine 80 mcg

Tabel 12. Kecepatan Alir dengan Syringe Pump Norephinefrine

Dosis (mcg/kg/mnt)	Kecepatan Alir (ml/jam)						
0,05	1,5	1,69	1,88	2,06	2,25	2,44	2,63
0,1	3	3,38	3,75	4,13	4,50	4,88	5,25
0,15	4,5	5,06	5,63	6,19	6,75	7,31	7,88
0,2	6	6,75	7,50	8,25	9,00	9,75	10,50
0,25	7,5	8,44	9,38	10,31	11,25	12,19	13,13
0,3	9	10,13	11,25	12,38	13,50	14,63	15,75
0,35	10,5	11,81	13,13	14,44	15,75	17,06	18,38
0,4	12	13,50	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00
0,45	13,5	15,19	16,88	18,56	20,25	21,94	23,63
0,5	15	16,88	18,75	20,63	22,50	24,38	26,25
0,55	16,5	18,56	20,63	22,69	24,75	26,81	28,88
0,6	18	20,25	22,50	24,75	27,00	29,25	31,50
0,65	19,5	21,94	24,38	26,81	29,25	31,69	34,13
0,7	21	23,63	26,25	28,88	31,50	34,13	36,75
0,75	22,5	25,32	28,13	30,94	33,75	36,56	39,38

0,8	24	27,01	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00
0,85	25,5	28,70	31,88	35,06	38,25	41,44	44,63
0,9	27	30,39	33,75	37,13	40,50	43,88	47,25
0,95	28,5	32,08	35,63	39,19	42,75	46,31	49,88
1	30	33,77	37,50	41,25	45,00	48,75	52,50
1,05	31,5	35,46	39,38	43,31	47,25	51,19	55,13
1,1	33	37,15	41,25	45,38	49,50	53,63	57,75
1,15	34,5	38,84	43,13	47,44	51,75	56,06	60,38
1,2	36	40,53	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00
1,25	37,5	42,22	46,88	51,56	56,25	60,94	65,63
1,3	39	43,91	48,75	53,63	58,50	63,38	68,25
1,35	40,5	45,60	50,63	55,69	60,75	65,81	70,88
1,4	42	47,29	52,50	57,75	63,00	68,25	73,50
1,45	43,5	48,98	54,38	59,81	65,25	70,69	76,13
1,5	45	50,67	56,25	61,88	67,50	73,13	78,75
1,55	46,5	52,36	58,13	63,94	69,75	75,56	81,38
1,6	48	54,05	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00
1,65	49,5	55,74	61,88	68,06	74,25	80,44	86,63
1,7	51	57,43	63,75	70,13	76,50	82,88	89,25
1,75	52,5	59,12	65,63	72,19	78,75	85,31	91,88
1,8	54	60,81	67,50	74,25	81,00	87,75	94,50
1,85	55,5	62,50	69,38	76,31	83,25	90,19	97,13
1,9	57	64,19	71,25	78,38	85,50	92,63	99,75
1,95	58,5	65,88	73,13	80,44	87,75	95,06	102,38
2	60	67,57	75,00	82,50	90,00	97,50	105,00
Berat Badan (kg)	40	45	50	55	60	65	70